

BENEDITO EDUARDO DE PAULA INTRIERI

HD:

MEDICO:

MEDICAMENTOS:

IMC

CIRCUNF. DE PESCOÇO

PA:

OXIMETRIA:

P = 112 Kg

07/07/21 P = 12.8

IAH = 2.7

m. de uso: 8hr.

lua

21/07/21 P = 13.5

IAH = 5.1

Fuga: 11.

m. de uso: 9hr - lua

Biologia - 12 IDO / 73 spO₂ < 90% /

29/07/21 P = 13.8

IAH = 7.7

m. de uso: 9hr

Fuga: 9.8

lua

06/08

P = 13.8 cmH₂O

21

IAH = 3.3/lv

Fuga = 21.3 l/min - compen

09/08

P = 13.8 cmH₂O.

21

Biologia: 69 IDO / 13 spO₂ < 90% lua

04/09

P = 13.8 cmH₂O

21

IAH = 1.4

m. de uso 9hr

Fuga = 40. l/min - lua

27/12

P = 13.8

21

IAH = 0.9

m. de uso: 8hr

Fuga: 52. l/min

lua

30/09

22

Entrego o CPAP

04/04
22 $P = 13.8 \text{ cmHg}$
 $IAH = 0.3$
M. de uso: 4hrs
Fuga: 45.9 l/min.
Bem adaptado.

fua

30/09
22 $P = 13.8 \text{ cmHg}$
 $IAH = 0.31$
M. de uso: 8h 10'

fua

14/12
22 $P = 13.8 - 5.0 \rightarrow \text{percentil } 10$ $\downarrow$ peso 110kg
 $IAH = 1.0 \text{ e/ev}$
M. de uso: 8hrs
Bem adaptado

fua

15/03
24 $P = 4.9 \text{ med} / 10.1 (\text{perc.})$ $\downarrow P_{\text{max.}} 11 \text{ cmHg}$
 $IAH = 1.4 \text{ e/ev}$
M. de uso: 7h 13'
Fuga = 8.2 l/min. , bem adaptado.

fua

16/05
24 $P = 8.3 \text{ med} / 10.5 (\text{perc.})$
 $IAH = 1.5 \text{ e/h}$
M. de uso: 8h 40m
fuga: 7.2 l/m

Bem adaptado

Natacha

$P = 8.4 \text{ med} - \text{Perc. } 10.8 \text{ cmHg}$

17/07
24 $IAH = 1.0 \text{ e/ev}$
Fuga = 5.4 lpm. (fuga intensa no início do ano).
fua.

16/01/25 $P = 8.9 \text{ cmHg}$ (mediana) $P_{90} = 11 \text{ cmHg}$
 $IAH = 1.4 \text{ e/h}$
m de uso: 7h 52'
fuga: 1.9 l/m

Natacha

16/04
25 $P = 7.7 \text{ med.} / 10.1 \text{ perc.}$
 $IAH = 0.9 \text{ e/ev}$
M. de uso: 8h 40'
fuga = 6 med / 26.1 perc.

Bem adaptado

fua

Nome: BENEDITO EDUARDO DE PAULA INTRIERI
Data de Nascimento: 26-6-1954
IMC: 36,57
Sexo: Masculino
Data do exame: 13-03-2021

Peso: 112 kg
Altura: 1,75 m
Medico: DR. CLAUDIO FERREIRA JARDINI
Medicamentos:
Histórico:

Lauda de Polissonografia

Exame realizado na noite de 13-03-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 502,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 150,0 minutos. O tempo total de sono foi de 451,5, eficiência de 89,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 74,9%; estágio N3: 2,7%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 60,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 84,9/hora, sendo elas 106 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 68 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 76%, permanecendo 33,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 81 bpm e NREM de 50 - 81 bpm.

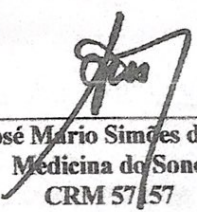
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 84,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=76%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157